

医保政策及DRG付费机制讨论

2026年4月10日 下午 4:05
1小时 14秒

关键词

医保 医院 患者 费用 门诊 药品 基金 医疗 耗材 医疗保险 医疗服务 项目价格调整
价格改革 数据标准 收费项目 筹资标准 成都市医保局 统一数据

文字记录

说话人 1 00:00

这个什么意思？公平，是不是就是说我们这个基本医疗保险它保基本，那除了基本医疗保险以外，它还有一些的保障是通过什么这个制度去，或者什么机制去这个填补的。主要现在国家还是在跟我们的商业保险的话，希望我们商业保险能够发展起来，去补充我们基本医疗保险负责的那个地方。

说话人 1 00:22

另外一个就是基金监管。基金监管是说什么？就是说我们的钱要花在刀刃上，每一分钱都要花上去，然后不要有过多的浪费，不要有过度诊疗，不要有欺诈骗保。然后导致我们的钱花到其他地方去了，那么我们这几年的工作都会围绕这四大机制去做。那么这个我们就说一下，就是落实到我们这个政策文件，落实到目前的工作中，其实就是这个视频可以很好的总结，这个也是国家医保局，他总结的一个就是从这七个方面去开展，去落实。我刚刚说那个文件健全多层次医疗保障体系，优化医保经办服务的体系，实施药品耗材的集中大量采购，这个实际药品后台集中大量采购，大家不要小看这个，是，其实这个是一个。改变了我们这个医药的一个供给侧的这么一个很重要的一个措施，为什么之前我们就说这个药品的流通过程中，或者是这个药品价格虚高，为什么这个价格下不去？其实不是我们医院加成的15%，大家可能知道，就是以前这个医院药品是有 15% 加成的，后来取消了15%，但是药价为什么还是高呢？其实不是医院加成的15%，是因为药品在流通过程中还有很多这个加价的问题，那么实施的药品集中大量采购之后的话，就是国家局去谈下来之后，就是这个用一种国家的这种。

说话人 1 01:49

手段，然后和这个厂商去谈判，把价格谈下来之后，就把这个流通环节中的水分给挤掉了，实际上这个是动了很多人的蛋糕的，就是为什么之前一直推不动国家局上来能够去推就说明他还是很有魄力去做这个事情。那么当然对于这个药品集中带量采购肯定还是有一些，它必然是动了很多人的蛋糕，所以说有一些反对的意见。那么怎么来看这个药品耗材的集中带量采购？就是药品耗材集中带量采购，其实可以大家理解为国家医保就下了一盘大棋，它实际上是要改变供给侧的一个什么情况？我们说一个比较普遍的一个情况，就是说比如说我们国内有很多仿制药，就说可能有 100 个厂商都在生产同一个药品。

说话人 1 02:32

那么100，这 100 个厂家都在生产同一个药品，那怎么他才能进到医院里面去呢？那可能就会有一些不太合规或者是不太好的一些手段，他就会导致了我在普通环节中这个药品价格的一个增加，那么国家就把它砍掉了之后的话，那你这个就是仿制药品，那么我就只允许可能在基地经过这个集中大量采购之后，就只剩下几家这个厂商了，那么剩下的厂商干什么呢？你要不就退出这个市场，要不然你就去找别人研发，让我们这个创新性创新能力能够提有一个比较大的一个提升。那么。比较差的这些你就退出这个市场，不要来浪费我们的医保基金了。

说话人 1 03:11

那么这个实际上和国外的一些政策是比较相像的，比如说我们美国他的仿制药实际上就只有一到两家厂，不会有很多，然后几十几百家来生产这个药。那么还有就是动态调整，我们医保目录的调整就是说我们要把更多更好的药，就是刚刚说把很多药品移出踢出去，然后当然要把很多药品拿进来，那么就有一个承前启后的这么一个作用。

说话人 1 03:35

那么深化医疗服务价格改革，进行监管和支付方式，就是我们刚刚讲的这个医院医保经济工作的三大主题。你现在是我知道医疗服务项目价格调整对我们医院影响非常大，特别是之前的放射的比较高的，对于这个医院影响非常大。那么说回大的政策的话，我们落实到一些稍微具体的一些东西，这个跟我们也是有关系的，比如说医疗保险是什么呢？他说医疗保险实际上可以把它理解为是一种我们主要是指的基本医疗保险，是为了补偿劳动者因为疾病造成经济损失而建立的一项社会保障制度。它只是一个社会保障制度，它是通过个人与单位来缴费来进行筹资的。那么建立这个医疗保险基金，那么当参保患者患病了，发生了医疗费用之后，这个医保经办机构给你一定的经济补偿，就是这个保险来给你一定的补偿。

说话人 1 04:30

那么这个我在保险里面的话就说了，就是我们医保基金是管哪一段？是管你生病那一段？就是目前有一些政策上说我们应该去管这个疾病的预防，这个在我们的目前的保险里面，就特别是在我们国家保险的就是医疗保险定位里面，它是不管钱的，那个它只管你从生病开始，当然说如果是花一些钱去做一些预防的。生病的这个概率会变小，当然也是可以的，只说在目前我们基保基本医疗保险在这个管理上面。还是更侧重于就是我们这个生病的，为什么就说有一个观点，就是说就是健康的第一责任人是我们自己，就说你不能完完全全靠这个医疗保险去管理这个，就是预防这个费用。对，是这样，那么有时候我们听说这个社保和医保五险一金，这些都是我们找工作时候都遇到，现在变成六险一金了。就是前段时间我们国家发了一个叫长期照顾保险，变成六险一金了，那么我们这个钱从什么地方来呢？这就是五险一金和六险一金医疗保险其实是六险一金里面的其中一个啊。

说话人 1 05:36

那么六险是哪六险？是医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和长期照护险，这个都是我们就是参加工作了之后的话，单位让给我们交的，怎么来交呢？这上面大家看到它是有一个缴费基数，就是我们的这个筹资是我们单位缴，我们个人缴组成的这个基金，那么单位缴多少呢？就是

交你工资的6.75%，就这部分钱是单，就是公司来帮你缴，缴了之后的话它会形成一个基金池，你生病的时候是不是用的就是这部分钱？当然这个钱的话，比如说用了，就是当你生病的时候才用的。

说话人 1 06:12

就说交到那形成一个基金池，在之后的话，大家生病了都从这个基金池里面去获得这个钱，那么这个钱交在交到哪呢？这就是一个统筹区的概念，就是比如说我们这个统筹区是什么意思呢？就是说比如说我们大家都是成都市参保的，那么都把钱交给成都市，那成都市就是个统筹区，那么德阳的这个职工他在他缴钱的时候他就交给德阳的医保，那么德阳就是个统筹区，那么统筹区和统筹区之间为什么要区分呢？是因为他的筹资能力不同，他的待遇保障水平也不同，所以说他要把它区分开。

说话人 1 06:44

那么德阳的患者生病了之后，他就用德阳的基金池里面。他是用不了我们成都的这个，那么我们成都的这个参保患者生病了之后，他就从成都的这个公司去拿钱，那么这个就有个区别，为什么说他的投资能力和这个大病保障水平会不一样？就是说大家知道这个保险它是个大数法则，他这个筹资人群越多，我资金盘子越大，他能够保障的水平就越高，或者是他那个就更经得起大家来用，因为他这个是个大数法则。

说话人 1 07:17

那这个下面这个就是我们成都市的这个筹资标准了，大家可以看一看，就是我们个人是有要缴费的，是要缴2%，但是这一2%是不调到我们那个就是。大家一起用的经营词的，这个是进入大家的个人账户的，就大家可能每个月都会收到短信，就说你的那个医保个人账户增加了多少？这个就是20%进到个人账户里面那个6.75%是我们是没有生病的时候用不了，生病的时候那么它有个缴费基数下限和上限，那么这个缴费基数成都市是有缴费上限的，就是每个月是2万22,000块钱，这个就是缴费上限，就是最多是缴22,500的2%。但是我省本级就不太一样了，省本级就是和成都市平行的一个主城区，它是没有缴费上限的，就是为什么。

说话人 1 08:04

这个就是以之前医院里面就是有人说能不能从省本级转到市医保，就是因为我们这个成都市是没有缴费的，省本级是没有缴费上限的，你工资越高，他缴的越多就缴，就是交到那个共用资金池里面就越多啊。那么医疗保险它分了几个类型啊？就是分了职工医疗保险和居民医疗保险，就是我们刚刚讲的那个筹资，是我们职工医疗保险，就是这个是由单位和个人一起来缴费，那么我们居民医疗保险是个人缴和这个就是政府的补助。那么之前还有一个就是新农合，新农合的话在2016年的时候已经被合并了，所以现在以前新农合是我们卫生行政部门建立一个医疗保险，后来他全部划归到我们这个，就是这个，我们的医保这边就是新农合，就在2016年就已经退出了，就这样，现在医保就是大家记住只有两种，一种就是单位职工的，就叫城镇职工医疗保险，还有一个叫城乡居民医疗保险。

说话人 1 09:01

城乡居民医疗保险可以理解为自己去缴费的，他这个缴费的水平是不一样的，城镇职工是每个月缴，城乡居民是每年缴费一次，那么大概是交多少钱呢？城镇职工，城乡居民的话就大概现在的城市是大

概800。那么我们职工算下来，根据，如果根据我们工资去算的话，就是刚按照说6%来算，他每年交的比其他居民要多得多。

说话人 1 09:27

所以说城镇职工在进行报销的时候，他的报销比例要比其他居民要高一些，这个大家理解，那么哪些能报，哪些不能报呢？就是这个我就做了一个，他是医疗保险，我们目前成都的这个政策就是住院能报，然后门诊上不是所有都能报，门诊上面的话它就是三类，一个是门诊特殊疾病，一个是门特，一个是门诊特殊疾病，就是我们叫简称为门特。

说话人 1 09:54

还有一个是特殊药品，特殊药品就是有一些这种比较高级的一些药，它在门诊上也是能报销的。还有一个就是这个门诊统筹，就是我们普通的这个门诊，门特和门诊的区别是什么呢？就是门特，它就是一些特定的病种，你要申请认定之后的话，你就获得这个相应的资格，就可以报销这个治疗这个病种，相应的药，比如说糖尿病、高血压、恶性肿瘤，这些都是属于一特殊疾病，申请之后获得资格就可以报销在门诊报销相应的费用，它的报销标准一般是参照住院的报销，当然每个城市不一样，然后成都的他的大病政策比较好，他就会参照住院，有些地方的话他们就不会参照住院，但是他会给你这个额度。那么门诊统筹就说他不限，他是不限病种的。

说话人 1 10:38

就是你在门诊上是可以进行刷卡结算的，一年大概有2,000块钱的一个支付标准，但报销比例大概是50%，就相当于你在门诊花100块钱，能有50块钱是能够报销的，是这个样子，这个就是我们说一下哪些能报，哪些不能报，一般来讲就是，当然这个是针对我们成都的有些地方的门诊政策报销政策比较好，比如说北京，它其实就没有这个门，它们都没有这种叫做特别的叫门特的说法，它们叫做门诊慢性特殊疾病的另外一种就是它们门诊上面的报销的政策和住院是差不多的。就是因为它们待遇保障这个水平比较好。

说话人 1 11:18

那么说了政策之后，就说一下我们医保办的职责干什么？就是做好患者服务啊。第二个是监管，你要少扣一点，然后我会讲监管大家多挣一点。然后另外一个就是支持我们科室员工的发展，支持其他地方部门的，一个就是数据分析，或者是支持他们的一些，这是我们的一个愿景。

说话人 1 11:39

那么说回我们院内的一些业务，就是我做了张图，这个不是我做的，我直接就拿过来用了，实际上我们现在针对于刚刚说的那个医疗保险，就是门诊和住院。的业务实际上就是三大业务，就是一个是住院审核，一个是特殊药品的一个审核，还有一个就是我们的这个就是门诊特殊疾病的一个业务经办。那么住院的话，我们主要是审核这个病人出院的时候那些费用哪些报，哪些不报。那么在门诊上面主要是办理门诊特殊疾病，就是我刚刚讲过门诊特殊疾病你要申请认定通过之后的话，你才能去享受这个相应的待遇。

说话人 1 12:16

另外一个就是我们的这个就是特殊药品，然后讲了特殊药品的话，就是有一些这种比较贵重的药，它需要经过一个比较复杂的一个流程进行审核。这就是我们目前的，对，就是对，这个就是院对患者的三大业务。那么我们说我们办理业务我们肯定是需要有数据的，那么我们整个数据是需要和办理业务的话，是需要和我们医保局去进行数据交互的。那么我们用的数据标准是什么？我们用的是国家医保局的这个贯标标准，这个贯标的话是国家医保局成立之后开始做的一件事情。什么是贯标？是什么意思呢？就是贯彻国家医保信息化标准，是这个意思，是。它的简称，那么贯标主要是什么？主要是统一数据的口径，以前的话每个统筹区我刚讲过，比如说我们和德阳，就是这个四川省和这个就是上海，四川省和重庆，他在办理业务的时候，他用的这个数据标准是不一样的，用的编码都是不一样的，那么国家在进行这时候就很困难，那么国家局、国家医保局成立之后的话，做的第一件事情就是统一编码标准，那包括了哪些呢？就是它有 15 项医保这个标准，包括了我们的这个手术操作，然后诊断，还有医保药品、医保服务项目和这个用耗材。

说话人 1 13:37

第四个，这四个类型是我们业务经办中的核心，另外当然还有上面的我们的医师护士，就是零售药店这些都是给了一个标准的编码，但是我们在院内维护的最多的就是可能数据这方面用的最多的还是我们下面就画这个椭圆形的这个范围。那么医师跟护士他做这个就是编码的话，主要是做监管型，比如说我们开的每一个医嘱，实际上通过我们的标准化的编码上传到医保局去了之后，他都可以进行一个统计，他总是。起到这么一个作用，另外一个就是它可以通过这个编码的统一，同时把我们的接口，就是这个业务经办的接口统一了之后，大家都可以按照这么一个标准接口去上传数据，那么国家医保它就有很好的一个数据基础去进行一个统计，它统计了要干什么？统计了肯定就是想要对医院进行一些相应的监控，以及就是对你医院整体运行情况的一个分析。

说话人 1 14:34

其实目前在我在国家医保里，在国家医保局的这个大数据的这个库里面，或者是在它的模型里面。我们是几乎是把医院运行的所有的数据，不是就是医疗业务方面只要是产生费用都是传给医保局的，他想调，你说哪个医生在什么时候开了什么医嘱，他都是非常清楚的，只是说他现在还没有腾出手来。

说话人 1 15:01

要整治我也不是说没有整治，就是前段时间已经整治的比较厉害，他只是说还没有通过这种很强的这种数据的这种方式来整治我们如果他想整治的话，这不是分分钟，因为这个数据标准全国都已经统一了，他可以通过很多比较的方式，大数据或者是 AI 模型的方式来把这些疑点数据真实很轻松的。

说话人 1 15:25

我看一下我们的编码，这疾病编码医保有医保，然后我们卫生有卫生的这个现在我们医保在院内用的是我们医保版。那么我们卫生这个行政部门在使用的时候，它是用的这个国林版，这个是有差异的。当然这个医保版当时在设计的时候也是做了这个相应的映射，那么这个是医疗服务项目代码，就是大家可以看到这个叫国家代码，就是当时讲的就是我刚刚讲各个省它是用了个编码，它的一个语言它都是不通的。

说话人 1 15:56

就是大家比如说我们这个静脉输液，辽宁省用的是一个，青海省用的又是一个编码，上海的就是地方码，云南使用是用的一个什么码？那么好，现在就没有了，现在也就用国家的这一套编码，对，一个码，那么这个药品呢？药品它是用的，它是以 ATC 编码作为这个基础做的一个编码就可以看得到这个。

说话人 1 16:21

我们现在医保用的这个药，就每个药它都是一样用的，它可以看得到它是什么类型的，什么什么剂型、什么规格，是哪家企业生产的，在这个码上面它都是可以体现的。我们要统计数据，这个药品这个还是比较方便，当然国家医保局要做监管肯定也是更方便的。那么我们的耗材它也是进行了一个编码分类的，它这个是分了就on可以看得到，就是比如说我们这个支架它是可以看得出来它是一个，是不是一个药品的支架？它是什么材质的？是不是一个永久涂层？哪个企业生产都是能够，医保局都是能够分析的，因为你这个编码已经上传给医保局，它是个标准的，所以说这个是比较，对于我们来讲的话，我感觉就是药品还比较好整，就是国家医保局肯定是下了很大的功夫去整我们的耗材，对吧？因为耗材的话。

说话人 1 17:18

在药品的话，所有的药品只有 14 万，但是我们的这个号的编码总共包括型号，算下来总共有 1,000 多万，但是国家药还是把它整下来，我为什么要整？就是便于后面全国的一盘棋，就是这方面的一个基础。那么就是这还有人员机构，我们的每个，现在我们的每个，我们每个医院都是有一个唯一的编码，然后我们每个医生护士也是有一个编码，那么这个医生护士的编码用来干什么呢？就比如说你开的这个医嘱出现问题的，我这个数据传到医保局去了。医保分析的时候就是你问题，到时候他就会来扣你这个医生的分。现在我们有个驾照是扣分的，一年 12 分，扣完了之后你就不能再给医保患者看病了，因为你给医保患者看了病，我们医保局是不支付这个费用，病人自然就不会来找你看病，这个对医生的影响是比较大的。

说话人 1 18:14

那么说了，我们的业务和我们的这个技术数据之后，就我们来说一下我们在管理工作中的两个重要事情，就是说刚刚讲到了就是监管少扣一点，第二是多挣一点，我们现在讲监管少扣一点，那么这个基金监管它是分了几个阶段的，就是刚刚开始的时候起步阶段。起步阶段是什么呢？都比较原始。比较原始，就是大家在审核的时候都靠人工，然后来慢慢逐渐探索，就是我们国家医保局，特别是我们国家医保局成立之后，出了这个对于医保基金监管是出了一套制度，出了制度之后的话自然就会有落实，那么它慢慢过渡到什么呢？就是我们的，就是从我们的人工逐步向我们的计算机审核发展，然后现在我们很多时候是依据我们的这个现场检查大数据来查我们医院啊。

说话人 1 19:04

那么还有一个就是他现在加强这个社会的一个协同监管，现在我们比较怕的及医务，比较怕的就是什么？就是患者投诉。有的患者投诉，还有一个就是同业之间的一个投诉也是比较多，那么这个可以说我们现在的基金监管已经从了我们之前的这个石器时代，变到了一个比较麻烦的时代了。就什么意思呢？就是说以前的检查可能就是某区医保局来，就是我们刚刚讲到就是我们成都市医保局来查一下就完了，现在不光是我们成都市来查，我们的四川省也会组织我们其他省的，就是其他市州的来，就比

如说泸州的过来查我们成都的。我们成都的当然也可以去查，比如德阳、绵阳它是个交叉检查，然后有的时候我们国家局还会亲自下场，就刚刚讲的，我们不是所有数据都传到医保局去了，医保局他有的时候会下发一些疑点数据，不是，有时候是常规，他会。这样话就一定要求医保局来进行检查，那么这个的话针对性就是比较强的。

说话人 1 20:06

那么以前在处理问题的时候，这个机制也是不是很完善的，现在在国家医保局，这个只要是说这个医保基金监管政治价位都是非常高的，因为我们的本身就是做过批次的，我们知道基金是我们的救命钱，不能就是被就是那个浪费。然后现在的专业化程度也是比较高的，手段和方式也是比较多的，那么频次也是比较高的。那么以前主要是查住院，现在门诊住院都要查，大家知道我们现在门诊上的业务量是比较大的，那么对于每一笔门诊的费用它都要去合理合规，这个就是我们监管难度比较大的。那么还有一个就是处罚的维度也是比较大的，也是变宽了。以前是经济处罚，是以经济处罚为主，现在的话是多维度了，那么我们就是涉及到我们的经济、生育和法律。

说话人 1 20:59

法制什么意思呢？以前我们和医保局之间的关系是一种协议关，它不是一种行政管理关系。什么意思？就是我们和医保局之间它不是上下级关系的。我们和医保之间是一个通过协议来约束我们的行为，它不像我们医院和我们卫生主管，它是一个就是行政管理的一个程序。那么在协议管理上面，如果我们违规了，那都是协议处理，它不是行政处理，也就是行政管理，那就是行政处理。但是我们现在医保基金使用监督管理条例出来之后，现在就变成一个行政管理，那么行政管理和协议管理什么差异呢？就是我们行政管理是会上网，那么就会对我们医院的声誉造成比较大的影响，然后我们领导也会很关注这一块。

说话人 1 21:43

那么监督方式我刚刚讲到了，以前主要是这个上级部门检查，那么现在的话主要是患者投诉也挺多嘛，那么我们在和上级部门检查的时候，在这个做沟通的时候，有的时候还是有些余地的，但是如果是患者投诉，我们一般情况下是很难存在争议的时候，我们的卫生行政部门，或者是我们的这个医保行政部门主要还是站在患者的角度上来进行解释，这个就是那么我们医保基金现在就是基本上不能避，不可避免就会。

说话人 1 22:14

一年有很多次检查，然后我们的责任也会向个人延伸，就是以前就说主要是处罚到医院，那么现在有医疗医师制度之后的话，他主要有的时候，这个有的时候医院就会反映我是管不住这个医生的，因为这个医生他比如说我在这个医院，我就说你处罚我，我就离职了，我换家医院就行。然后他实际上造成的损失医院的，对的，那现在为了解决这个问题，他就说他的处罚是可以延伸到个人医生上面，医生受了处罚之后，他会带着这个扣分到其他医院去，那其他医院可能就会有一些顾虑，那么问题承不住也不可避免。为什么？就是现在的患者投诉实在是太多了。

说话人 1 22:52

只要是投诉的话，基本上都是要处理，那我们看一下这个医保机的监管，最近查了这些钱了，就说飞行检查的话，平均每家医疗机构平均 440 万，只要是国家非检，去你家医院不可能查不出来问题，就说这个问题情况还是比较复杂，不是说我们医院做不够，是因为有的时候我们的政策的要求的颗粒度和我们管理的颗粒度还是不能很好的匹配，那么自然而然的话，他如果严格按照我们的政策来进行一个核查的话。那么你这家所有的医疗机构都是有问题的，我不能说啊。其实我都不敢打保证说哪家医院这个完完全全没有问题，我觉得这个很难，非常难。

说话人 1 23:35

那么为什么最近也加大了这个监管？就是刚刚讲的，比如说我们现在是有一些这个当期数据，大家可以看到当期是个负数，就是说今年我投资可能只投了 100 个亿，但是当年我用了 100 个 3 个亿，就是我基金出现一个赤字。为什么呢？基金是以收定支的，那以收定支的话你就不能出现赤字，比如说你有多少钱办多大的事，出现赤字的话这个费用。

说话人 1 24:04

建设长期运行是不见的，那么刚刚讲到的就是一个线上检查和问题投诉，这个就是我们一年可能要搞几次自查，主要就是要应对医保对，我们现场检查，我们自查完了之后医保不会来，我们自查是什么呢？就是我们先把钱交了之后，医保现场检查，查到相同的问题可能就不再做处罚了，这个是患者投诉，这个大家不要觉得这个东西现在出现的我们很重视，就是因为现在很多患者他都是这个都很基础的。

说话人 1 24:36

就是这个，我老家是安徽的，当时我看到这家医院，我就觉得他们很太不重视，就是这个博士把他那个费用清单拉出来一看，会发现给我很多这种明显逻辑上不合规的。就比方说按日收费的，你收费超过住院天数，这个是不太合理，对吧？那么这个按小时收费的，你一天基本超过 24 小时，这个也是有问题的，就是一看就会觉得有问题，那么他们的费用清单会看太。还有什么重复收费、分级收费，不属于医保支付范围的，纳入医保支付，这都是问题。

说话人 1 25:06

那么这个他可能是通过这种，就是他常规看都能看得出来，问题还不要说现在有些 AI 的这个，他只要在 AI 的加持之下的话，我们这个费用现在有时候就没有办法，精力就是能够经得起我们这个就是 AI 的人群很多现在患者也是通过 AI 的方式来找我们进行一个要求，我们进行回复，其实也不是说他说的不合理，很多时候 AI 回复的东西我觉得还是很有道理，但是你要把他这个按照这个标准政策的。

说话人 1 25:38

方式去给病人做一个回复还是挺的，那么哪些问题我们需要注意这个就是我们医保基金就是有哪些行为可能是要被处罚的？什么分解住院挂床、住院过度诊疗、分解处方、超量开药、分解项目收费、违规收费这些大家听这个名词大概就知道是什么意思，就是说这个在收费方面可能是有些问题，也或者在过度诊疗方面是有些问题，你看这里面也是这个，就是我们医保协议上面列明的，就是我们不能去做的一些事情，大家可以看到这里面很多都是和收费有关系，当然了。

说话人 1 26:17

和这个过度诊疗也有关系，就是我们医保支付是根据我们的诊疗的规范和收费的规范来进行医保支付的，如果你的诊疗的规范和我们的收费的规范都达不到的话，那医保支付自然有问题。然后这个就是我们国家局统计了，就是目前来说哪些是常见的问题，就是出被处罚最多的，就大家可以看到就是说收费方面问题是处理最多的，但是就是关于就是我们合理诊疗方面的，现在医保局也越来越厉害了，说这个合理诊疗方面的问题也是比较多的。但是收费方面的问题，为什么现在是比较多呢？因为我们这个收费目录是 2003 年版做的这个基础目录，然后有 20 多年这个没有大的变动，那么自然而然很多政策可能跟不上我们医学的发展，那么就会出现一些标准不太明确，或者是就是我找不到我们做的开展的一些诊疗活动，找不到收费项目，这种情况自然而然我们收费的这个问题就比较多。

说话人 1 27:19

那么大家还记得我刚刚开始讲的就是说为什么现在要进行医疗服务项目价格改革是一个主题呢。就是现在医疗服务项目价格改革，主要是解决之前就 2003 年那一版对收费目录里面存在的一些矛盾和一些问题，就希望通过这个医疗服务项目价格改革来解决这些，就是理顺我们的医疗服务项目价格。

说话人 1 27:41

那么我们可能我们在监管时候，我们也用了一些 AI 的一些手段，当然这个都比较初级的，就是我们这些药品的话都是有一些报销性条件或者说明书的，那我们在上规则的时候，我们可能就要用 AI 去匹配，就帮我们理下规则，这个是我们之前做了一些尝试，当然这个是比较初级，给大家展示一下，就比如说还就是我们去看我们的手术记录是不是完整，因为我们的手术记录，我们要求我们的手术记录是要跟我们收费要一一对应。

说话人 1 28:07

也是一一对应的，就至少要有相应的描述，那我们就可以让 AI 去帮我们跑一下哪一些，比如说我这个手机记录是不是写得比较完整？比如说我们那个货币切口上修补，你收了这个费用，那你的手机记录里面要体现出来，那么用 AI 的大的模型宣传去做这个相应的工作，做一些指控。

说话人 1 28:26

那么做这个讲完这个监管，刚刚讲的这些都是监管，就是我们监管方面要更透一点，那我们 DRG 方面要多挣一点，就是大家可能也对这个 DRG 现在比较多了，那我今天我想给大家讲一讲就是 DRG 的一个原理。希望能给大家讲懂，那么大家可能在今后的工作中能有些帮助。

说话人 1 28:47

DRG 的话，实际上它就是一个分类工具，我们还是讲通俗一点，它就是一个分类工具。为什么要分类？分了类之后它就像一把尺子一样，它就可以进行相互的比较了。就是大家可以看到，就是把把这个临床过程相似、资源消耗相近的分到一个组里面去，那么它既然是有了一把尺子，它就可以进行绩效的考核，医疗质量的评价以及医保支付的一个应用。那么我们知道这个医疗质量的评价里面就有一个叫低风险组死亡率，它就和这个我们的 DRG 有关系。

说话人 1 29:18

低风险组死亡率什么意思？就说。我分组了之后的话，有一些 DRG 组在历史数据上面看起来他的死亡病人很少，你某家医疗机构突然在这个 DRG 组里面就出现了死亡患者，那你就会怀疑你的医疗质量是不是出了这个问题。那么分组了之后的话，大家都在一个池下面的话，那我就可以去划一个就是我们支付标准，那么就进行一个医保支付，当然是可以的，那么绩效评价就当然更可以，就是大家做同一个病种，然后给同样的钱就行。

说话人 1 29:49

那么我们 DRG 怎么来算？今天要跟大家讲讲这个公式，我觉得要和大家讲一讲，不然的话大家可能对这个 DRG 的理解都不是很深入，就是。对。他这里执行 DIP 之后的话，就是有一个核心的概念，就是医院治疗一个患者能够得到的一个总费用，它是一个固定值，绝大部分情况下是一个固定值，这个固定值是怎么算出来的？它是等于点数，乘以点值乘以调整系数。点数就是指每一个 DIP 组它都是有一个固定点数的，点值的话就是每一个点数它那个点值每年会根据医保基金的总盘子去进行一个计算，那么调整系数是每家医疗机构会不一样。当然为什么会不一样呢？就是我们医院和省院就不一样，那么我们医院和这个三院也不一样，它是根据医院的一些客观条件来进行一个评价的。比如说我们的，我们是国家医学中心，那么我们可能收治的病人更重一点，所以说他在调整系数上面就多给一点他，这个每家医院是不一样，他一般不会超过正负 5% 这个调整系数，大家不要小看这正负 5% 已经很多了，因为他是按照百分来算的，然后正负 1%，因为我们医院的整体量，比如说我们四医保一年 10 个亿，那 1% 就是已经是 1,000 万。

说话人 1 31:11

那么我再来解释一下，就点数乘以点值乘以调整系数，一旦确定下来之后的话，这个就是你治疗一个患者能够得到的总费用，这个总费用它是等于医保基金给我们的，加上患者给我们的，它加起来是个固定值。什么意思呢？比如说我的点数乘以点值乘以调整系数，算出来是 1 万块钱，那么我从医保局和患者那拿到的也就是 1 万块钱，这个和患者给我医院多少钱没有关系。假设患者在我们医院治疗的时候给我 4,000 块钱，那么我从医保局拿回来就只能拿回 6,000 块钱。加起来是 1 万块钱，是个固定值。如果患者自付是 3,000 块钱的话，我们医保局就拿回了，就能拿回 7,000 块钱，加起来还是 1 万块钱，所以说 DRG 的话算支付标准的时候，大家一定要注意，它算的不是医保局给我的部分，是一个总的费用。

说话人 1 32:03

那么我们再来看一下点数和点值什么意思？就我刚刚讲的每个 DRG 组都是有一个点数的，那我们就来看一下这个点数是怎么看的？比如说我们现在的泌尿外科碎石，就是我们标黄的这个不伴何种类并发症，它的点数就是 131.61。什么意思？就是我治疗一个。这个泌尿外科碎石的这个患者，他能够做到挣到了这个点数，我们可以理解为他就是个公分，我就挣 131.61 个公分，那么这个点数怎么算的呢？他是跟那个历史的次均费用这个有关系的，次均费用越高他这个点数就越高，那么这个点值是怎么算的呢？就是就是我们打工，其实现在我们知道打工治疗一个病人能挣这么多，一个点数能挣这么多，一个公分的，那么每个公分值多少钱？那么我们就。

说话人 1 32:54

这个医保局，我刚讲的这个统筹区的概念，我们这统筹区今年所有医院打个工就是挣这个公分，总共挣了就是 8,500 万个公分，就是治疗所有患者之后会折算成这个公分，那么每个公分值多少钱呢？比如说我今年医保基金是 100 个亿，那么我每个公分就是用这 100 个亿去除以 8,500 万个公分，那么一个公分算下来，比如说我们这个算下来就是 107 块钱，那么我们治疗一个泌尿系统最直的患者能够得到的总费用就是用我们的。积分就是这个点数，就是我们挣了多少个公分去乘以每个公分值多少钱，再乘以我们医院的调整系数，就下面这个公式，就用 131.6 个公分乘以每个公分值 117 块钱，再乘以我们医院自己调整系数，这个就是我们治疗一个这个碎石患者不伴合并症与并发症，这个患者能够得到的总费用就是 15,000 块钱。

说话人 1 33:50

刚刚讲到根据前面的公式，这 15,000 块钱包含了两部分，一个是医保给我的，另外一部分就是患者给我，加起来是个固定值。如果我们治疗这个病人的住院费用超过了这个 15,000 块钱，那么我们在账面上就是个亏损的，如果我们的住院费用低于这个的话，就是一个结余状态。

说话人 1 34:12

我们再来深度理解一下这个公式说，比如说就我还是以这个举例，就算刚刚是算下来，就是我们是一，就是 131.61 的公分，然后每个公分是 117 块钱，然后算下来总共是 15,000 块钱，那么假设我治疗这个医院，治疗这个患者，他的费用总共 2 万块钱，这个医院在医院医，患者在医院里的报销比是 80%，患者自付 20%。

说话人 1 34:37

那么患者在医院结算的时候的话，这个就用 2 万块钱乘以 20%，就是患者付给我们医院的，就是付，就是他就现场结算的时候就是给我们 4,000 块钱，那么我们去找医保局要钱的时候就是不好意思，不好意思就是患者在我们医院的话，他只付给我 4,000 块钱，但是我们。是在账面上花的是 2 万块钱，那 16,000 块钱理论上是我去找医保局要的，但是我能不能要回这 16,000 块钱？以前按照项目付费的时候，我是可以把这 16,000 块钱要回来的，但是现在按照第二计算，它就不是这种算法了。

说话人 1 35:14

就刚刚讲，根据我们上面的公式，我们因为能够拿到的总费用是 15,000 块钱，因为患者已经给了我 4,000 块钱，那我从医保就只能拿回 11,645 块钱，那么我给患者垫付了，因为患者在医院里面报销了是 16,000 块钱，我给病人垫付了这 16,000 块钱，但是我从医保就只能拿回 11,000 块钱，那么这个就账面上就亏损了。

说话人 1 35:36

这个是第二季的算法，就按照这个公司来算，就是我给病人垫了不一定都能从医保这拿回来，怎么算？就是根据刚刚的公司来算，那么我们在假设这个另外一个病人，我们做下来是 12,000 块钱，还是按照刚刚那个报销比例，那么患者在医院里面结算的时候，他是给我们医院 2,400 块钱，那么我们根据这个点数乘以点值算下来，是这个就是 16,000，就是这个 15,000 块钱，那么我们从医保局就可以拿回来多少钱呢？拿回来就是 13,245 块钱。

说话人 1 36:10

但是病人在用，我们医院里面，他给我们医院给病人垫付了多少钱？就是用这 12,000 块钱乘以百分之八十，就是我们垫付，就是垫付的 9,600 块钱，但是我们从医保就可以要回来 13,000 块钱，那么这个就是我们结余了，他们只要结不结余，这个只是举个例子，结不结余主要是看我们咨询费用，那么这个咨询费用看的是总费用，不是医保报销的那部分。

说话人 1 36:33

整体来说的话，这个咨询费用是怎么来算的？或者是大家怎么来理解这个咨询费用？就是我们这个同级别，就是我们比如说我们成都市三级医疗机构治疗这个。泌碎石不办肾内并发症的一个平均费用，就比如说我们就是所有的三级医疗机构在做这个，就是碎石的时候都是 15,000 块钱，我们做出来 16,000，那么我们超过了这个就是亏损。那么怎么办呢？他那个比例是咋定的？比例是这样的，比例是每个病人报销的时候，他都是有一个自己的一个比例的，有的人是 85%，有的是可能是 87%，这个比例是我们医院决定不了。

说话人 2 37:16

也是医保局。

说话人 1 37:17

对，医保局决定。

说话人 2 37:19

那他咋不建议那个 15,645 乘以 20% 呢？

说话人 1 37:25

这样子，我刚刚就是这张 PPT 少了一张啊。什么意思？就是病人在医院里面是按照项目来结算的，按照项目来结算就是他花了就是 2 万块钱，在报销的时候，他就是以 2 万块钱的基数来报销，不是按照 16,000、15,000 来报销，这个是 15,000 块钱，是我们医保在给我们算我们院能拿多少钱的一个东西，这个患者是看不到这个钱的，就是一这 15,000 块钱是跟患者没有任何关系的。

说话人 3 37:53

但是相当于在结算的时候是按照项目去报销，项目报销他根据你的甲乙丙类去做这个细分。然后算出来就是医保给你报多少钱？在医保报这个钱是由医院垫付的，因为你只给了自己，而医院。

说话人 3 38:11

If you have a good show.

说话人 3 38:17

点数那个来算，他有一个上限金额，减去你刚刚支付的这个金额，剩下的这笔钱才是他拿给医院的，可能这笔钱比你在现场报的基金高或者低。

说话人 2 38:30

我觉得是因为医保的导向是让大家要互相之间要来最终的趋于一个平均值。就是就因为高了的他可能就亏，低了的他就有结余，但医保的目的是为了获得你平均的一个值，大概均线回归，他最优的肯定就是大家独立的病种，基本上就是在 15,000 左右，然后这样子整个就均衡。而如果你那种方式的话，对于医院没有动力，因为医院反正一个病它最后怎么会过的？它你说2万块钱患者反正剩下不足的部分就是患者补，那医院是没有动力去优化它自己的，让医生去降低患者不该花的，就。

说话人 3 39:14

降低成本。

说话人 1 39:15

他就没有这个动力了。对。

说话人 2 39:16

所以医保的导向它就是这个导向。

说话人 3 39:19

像以前我们在玩项目。

说话人 1 39:21

我们说的对不？

说话人 3 39:22

对对对。以前我们在玩项目支付的，相当于就是医院跟患者之间在一个PK。但是玩第二季的时候，实际上在 1 月之间再做一个匹配，在一个内卷，对吧？

说话人 1 39:32

对，然后我说一下，就是说这个我们现在的第二支付有一个前提叫总额预算下的，就是第二支付，就是说这个基金盘子永远是不会穿的。什么意思？就是我们的工作量越大，工作量越大我们的点数会越低。什么意思？就是说比如说我们全就全，成都市的所有医院都使劲干，就是大家的业务量都增加 20%，但是你能拿到的钱不一定增加了。为什么？因为我们医保基金今天只有这 100 个亿来分。我这边20%。

说话人 2 39:59

跟我们发奖金的逻辑差不多。我退。

说话人 1 40:02

反正就是大家看最后来。这个盘子是不会因为你增加了 20% 的工作量，就给你多发 20% 钱，这是不会。

说话人 2 40:10

我，我真的。

说话人 1 40:16

然后是这样的，就说根据这个 DRG 的这个管理的这个原理，就说实际上就是要去纠正，就是今天我们去临床科室培训的时候，就有一个，有两个误区，就是第一个错误的认识是什么呢？就是我们现在在讲 DRG 是怎么管理的，就是第一个就是要纠正医生的一个错误的，一个认识，错误认识一就是只关注，就是很多比如说我们护士老师，他都是，比如说护士长老师他那个，他哪怕一根针、一根线他都想把它给收起来，他只关注药品套餐能不能收费，他不关注成本。

说话人 1 40:51

什么意思？就是大家可以看到在 DRG 里面的话，你的药品套餐能不能收回它其实不是最重要的东西，因为你收不收它，它就只给你那么多钱，对不对？所以说我们关注的是那个成本，就是你这个药品套餐你该用不该用。第二个的话就是他认为这个患者的自费和 DRG 没有关系，实际上在 DR 数法付费下面这个自费项目也是和这个医院的收入是有关系的，就是因为加起来是个固定值，你不要觉得我收患者自费收的多了，然后我医院就挣钱其实是错误的，因为加起来是固定值的。那么所以说的话就需要从几个方面去开展我们的管理。

说话人 1 41:28

对，第一个就是我们的这个分项首页诊断的填写，因为刚刚讲到你这个家一定要分组，你一定要首页填的不准，那分组就错了。那么特别是对于外科室的，外科室他们的那个 DRG 分组有的时候一个诊断。一个诊断有可能会影响几百个点，100 个点，大家可以看到一个点是 117 分 117 块钱，那么你少一个诊断有可能会少 1 万多块钱，这个是一个。

说话人 1 41:53

第二个就是合理诊疗就合理，为什么合理诊疗呢？主要就是说我们的药品、耗材都是合理性，就会使我们的成本。合理的降低，那么我们和其他医院就更有优势了，大家都是 15,000 块钱的支付标准，我们做下来之后成本只有 14,000，那我们可能就结余了，就 1,000 块钱啊。其他医院成本控制不好，它是 16,000 块钱，那么它就有 1,000 块钱的一个亏损。那么还是合理合规收费，避免重复收费、分解收费，不要错提漏提。为什么不要重复收费和分解收费呢？因为在家医上面已经没有任何意义了，因为你不管收多少钱，它都是它都给你这个标准，你收多了之后的话，反而它会被医保进行监管。

说话人 1 42:33

那么出院带药以前那个医保的协议上面是不管出院带药。那天我们在开那个，就是会的时候，就是有个就是药剂科在反映有些科室他可能虽然大家要带几箱，到时候把我们惊到了，就是人家医保上面就说了，人家写的协议上面说了，慢性病是不超过，慢性病不超过 7 天，然后急性病是 3 天。

说话人 1 42:54

那么现在人家医保协议根本就不行，你想开多少？但是都是你医院自己的成本，自己亏了你，你要给，就是你要做这个慈善也可以，没问题。然后第二，然后另外一个就是要优化我们的病组和费用结

构，对于我们医院来讲的话是可以优化这个结构的，很多医院他是没有这个病组，没有优化这个。我把的，因为他病人都收不满他，如果科室空转，他亏得更厉害，那么这个对于我们医院来说，还有一个是费用结构的优化，费用结构的优化里面有个很重要的，就是集中使用，就是要合理使用的药品，药品的耗带量采购的这样套餐。我举个例子，就是之前我们在心脏内科冠脉支架集采之前，我们一个冠脉支架，一个支架是 12,000 块钱，集中采带量采购之后，谈判之后变多少钱？变成 800 块钱，他90%。假设我们医院就一定，我们医院就是要，就是一定要用那个 12,000 块钱的那个支架啊。

说话人 1 43:50

他不用那个就集中带量采购的支架就会出现一个什么情况，就是我们院的成本比其他医院高，那么我们就相当于说我们医院在给其他医院抬轿子，帮其他医院打工，因为我们是我们用很贵的耗材把这个病种资源费用抬起来之后，我们的费用是高于这个资源费用，那么你就相当于帮其他医院打这个，就是我们这个 DRG 付费的一个产品，就是说怎么样让医院多挣钱呢？可以从这几个角度去进行一个，开展一个相应的工作。那么今天跟大家。就是介绍的内容当中这些，看大家有没有什么一些问题，或者是一些想要交流的一些内容。

说话人 2 44:35

再问一个。这个你这么想哈，就是，那不是，就是对于这个常见病，对吧？来讲，相当于能够治疗的医院越多，大家这个成本就越透明嘛。成本就越透明，那么对于我们医院来讲，像我们这种医院来讲，你人力支出又大，然后耗材有的时候用的又还比较好。对。那可能人就更，就不占优势。前面所提到的那个就是调整系数，它是应该来讲就是为这种各不同医院的情况所预留的一个调整的一个渠道，对吧？

说话人 1 45:13

对，就算就在解决这个问题。

说话人 2 45:15

你给大家介绍一下，就是我们现在所开展的哪些业务，或者所做的哪些工作，就是为了让医院去争取这个调整系数能够往更高的调，为什么呢？因为我们日常也会接到非常多的业务需求，其实有的时候我们会跟大家讲说跟临床业务相关的，跟医院这个营运营有关的，我们其实应该把它放在优先支持的这个地位上去，但是在这个里边，还有这个里边也会分层，我个人觉得跟这个调整系数有关的工作更应该是这里边重点关注的，比方潘阳那边的当。我不晓得，就是现在运管搞的那个当日入院，当日手术，他跟我理解，可能跟我们的病种结构调整和我们的业态调整也是有关系的，你能不能给大家介绍一下这个吧？

说话人 1 46:06

是这样的，就是调整系数，确实是，就调整系数就是解决我们刚刚讲到的，就说我们医院和医院之间有差异，有可能我们收治的患者更重一些，那么就如果大家调整系数都一样的话，对于我们院还是吃亏的，那么这个调整系数一般是怎么来算的？就说每一个区哈它的这个调整系数的计算方式都有点不太一样，但是一般会和什么。

说话人 1 46:28

相关和我们医院的运营效率有关系，比如说我们的还有一些比较，还有一些医保指标运营效率主要是和我们，比如说床位周转率，然后还有就是我们的这个，就是如果是运营的话，主要是指的是这个床位周转的一些情况，还有就是我们医保里面考核的一些指标，就比如说我们的自费率是不是比较高，是高于同级别的医院，还有就是我们的这个 DRG 里面覆盖的一个组数，就比如说我们这个，我们收治的我们科室比较全。那么我们 DRG 覆盖的这个组数就比较多，那么就说明我们的这个能力比较强。还有就是我们的一些中心的建设，就比如说我们是大学附属医院，那么它是要加分的。还有就是比如说我们的这个，刚刚讲到我们也是这个区域医疗中心，它这个也是要在调整系数上进行一些考虑。

说话人 2 47:24

新技术和疑难重症的这一块会对它会有影响吗？

说话人 1 47:30

新技术和疑难重症的话，目前来说的新技术目前是没有，因为新技术它一般在第二季里面是单独特别单一的，那么疑难重症它主要是体现在一个整体的 CMR 上面。是这样，CMI 越高，调整系数也会越高，是这样。

说话人 2 47:43

所以我们一直调调结构里面，就是要把这种。常见病要通过这种转诊的方式，在一点体内，大家要更多地去消化，然后通过这种上转，或者说有一些方式要把这个更疑难重症的一些患者，有价值的患者到医院这边来做进一步诊疗游戏可能也有这个好。另外新技术的开展的话，就是因为他还，他可能还没有进入到这个体系里面，就是他根本就针对这种，有一些他还没有说这个病种就一定值定多少钱，他是可以单独地去申请的。

说话人 1 48:17

单独分析。

说话人 2 48:20

行，那个刘然是不是在负责医保的数据的那个？

说话人 4 48:24

这个我我不知道，我是医保的专员，但是我是药剂和设备的专员，因为医保它有那个什么说要抓药剂和设备的数据东西，所以说有时候会流到我这里。那我听这个，我其实之前我确实不懂医保卡，对，但是我觉得还是有点，我想说就第一句话就是那相当于就是要降低我们患者的费用，是一个目标，实际上是降低成本，降低是我们降低，合理地去控制我们的成本，是一个。因为现在我知道药这个设备大量的在做集采，并且什么集采数据，而且到了人，但是对于那这块他的医疗质量咋保证呢？还有东西可能会不会用的不是那么的好？

说话人 1 49:17

是这样的，就说我说一下关于集采的，我个人的这块，就是这个集采的话，他不是说集采的东西他的效果就不好，因为现在没有任何的数据说我们集采的这些药耗材就和原研的有本质的区别。另外一个就是在这个政策的调整过程中。我们为什么要去做这个集采？我刚刚讲了，主要是要重塑我们这个，就是我们的这个供给侧的这个市场，因为这个市场之前确实是存在一些问题，不通过集采的方式没有办法解决这些问题，这样的。

说话人 4 49:53

第二个就是那个要降低费用的话，我理解这个费用是动态变化的那个标杆费用，也就是说大家都在这卷，这个费用会越卷越低。那这个其实是造福了国家的基金盘子和患者，但是不是会加速医疗服务的寒冬？

说话人 1 50:13

是这样的，刚刚我刚一讲。其实越减越低，其实也没有什么问题。为什么呢？我刚讲了那个医保基金，它的收入是一个固定值，那 100 个亿就是我们把费用减低了之后的话，实际上它的点值会变高，你懂这个意思吗？就是这 100 个亿一定是会分给你的，就是说因为我只有这 100 亿，我不管你怎么做，这 100 一个亿都是会分给你的。就是说我们去卷，当然卷下来之后它的点值会变高，是这样，它只是一种分配方式，就是大家都卷，把费用卷低下来之后，我们点值反而会变高，当然你是要合理的去卷。就是大家一定要就是有这么一个想法，就是医保局他不是说怕花钱，他是 100 个亿，今年因为他的预算管理，我收多少钱就用多少钱，你没有钱的话我就没有办法给你了。那你说医保怎么办？他只能采取这种方式。

说话人 4 51:06

他 100 个亿他是固定的，还是每年会往上增呢？

说话人 1 51:10

每年是就看我们的筹资水平，当然我们说现在经济水平是往上的，但是就是我们的医疗需求增长的趋势很快，哎，这个，这可能就是一个目前的一个矛盾了。

说话人 2 51:25

所以其实这个里边有几件事情特别重要。一个就是我们说的那个一组主数据，其实一组主数据里我们还涉及到几个数据的一个对码的问题，对吧？你的医保码和医院本身的那个那套编码，还有可能和医疗，就是你刚才讲的，我理一下那些对标就特别重要，那个各个系统里面现在一组主数据，所以我们今年开展的跟两两整个部门要跟大家一起开展的医保的主数据的建设和医保对码工作。因为现在永强这已经去年开始，那个t恤应该也知道。就是财务那边，我们物价专班所接的那个叫什么？叫什么来着？什么什么项目调整？

说话人 3 52:09

就是医疗服务项目，就像指南这一套。

说话人 2 52:13

指南变得好多，而一变了以后各种的这个管控规则，刘然刚才讲的那个医疗质量的问题我理解，其实现在这件事情它就是要合规，就是要保证医疗质量，同时也得让医保基金更合理地去使用它。其实两边是一个，也不能叫博弈，应该是它想要去平衡这个里面的关系。所以我觉得一个就是刚才讲的我们后面的业务中间其实大家都应该关注这个事情，为啥我们每一个人的这个利益其实也跟医院的运营是完全绑定的？所以我们后面我们在碰到这个新技术开展相关的工作，我们的业务形态变化的这个工作，我们各种的这个患者上转下转，包括我昨天在群里面发了一个新的这个新的整个医疗卫生机构的调整，强基、控二、稳三。或强基稳二控三，对吧？这个出来了以后，关于会审转诊这个业务肯定是非常重要的事情，大家都要去引起重视。第二个就是我们医保组，我们组数据的整个的建设我们可能真的还得要再加强力，否则的话后面各个系统里面这个医保这个组。

说话人 1 53:30

不知道，没怎么听。

说话人 2 53:32

分散了以后，各种管控规则又要独立地去跟各个系统去做对接的话，这是一件很崩溃的事。所以你那边的那个收费项的那个事情也得要。

说话人 3 53:43

其实相当于就是我们只要最近一两年随着这个立项指南各种落地，然后而且时间也出来，然后基本上各种管控，但我们这些管控目前来说基本都是基于一组这一块，对，他是在开单的时候都管控。但是这些立项指南一落地，我的一组就存在着增评、改、替换这一系列的东西，这些一组一变，比如说我以前的管控。他这个一组失效了，对吧？那新的一组我又不知道这个没有同步性，没有及时同步的话，很容易就导致这个管控失效，就会直接影响到我们的医保基金的一个不合理使用，包括影响我们整个 DRG 的这个费用的一个上升，从而导致可能该是赚的变成亏损了。就是基于这一整套来说的话，实际上这个一组的这个跟各个系统之间像涉及到规则这一块的这个联动。实际上我哥感觉这个趋势是影响越来越大，而且后果也是。

说话人 1 54:47

对，越来越。之前医保局成立之后，第一件事抓监管，也不是抓监管，第一件事是统一标准，就是只有医保。我感觉目前只有医保能做这个事，因为只要是涉及到钱的，医院都会很重视，因为我们那个每一个编码它都是涉及到钱，如果不涉及到钱，你想把这个编码统一了，我觉得真的很难。

说话人 1 55:10

为什么医保局能做这个事情？第一件事情是抓标准，第二个事情是搞。监管第三个事情就是做我们的这个就第二期付费，第四个事情就是刚刚何老师说到的就是我们的医疗服务项目价格调整，这个是非常重要的一个东西，他这个医疗服务项目价格调整他是最后才启动的，为什么错了？因为这个没事，这个东西是有 20 年几乎没有任务，想要去动这个东西还是很艰巨的一个任务。第二这个对我们医院影响非常非常大，特别是我们之前就是我们的放射那一块，就是我们的 CT 磁共振调价了对我们医院收入的影响非常非常大。对，看他的，考一次。

说话人 5 55:51

可以，这还有个问题，就是最后一页说到了一个不要带检查和治疗出院。那是不是说住院患者出院前应该把已经开了的检查和治疗做完之后才出去？

说话人 1 56:05

理论上讲就不应该有这种没做完的，然后就给他出院。是，就是不带检查项的，就是因为现在医保协议上也没有说你不能带检查，但是在 DIP 上面我不建议啊。另外一个就是我们鼓励，如果是，如果你比方说有一些病人他要出院换药，他能够缩短你的住院床日，我们也可以。这个主要是看医院整体管理怎么来管理，就是可能要到每个病，当然如果这个检查和治疗本身应该在住院期间做，你没有做，然后出院了这种是一定要把它处理掉。

说话人 1 56:41

为什么？因为这个有可能医保现场检查的时候，他会把这个钱给你扣掉，因为实际上是因为怎么说？就是比如因为现在第二是我刚刚讲到的，你治疗这个病你只能得到这个固定值，你把现场检查了，发现你这个没做，他又给你扣，又把这个钱给你扣掉了，实际上你就损失了。以前，以前他这个按照项目来付费的时候，这个不是损失，为什么？因为你实际上没去做，没有消耗成本。但是 DRG 付费里面他已经把这个钱给你了，再从你这个总额里面再来扣，你就是实实在在亏到你的这个成本上面。

说话人 2 57:22

但是我们现在临床上确实存在着他，可能患者觉得他术后要来检查，他把术后检查的这个检查开了，但是在结算的时候，因为我们现在并不是强管控，对吧？我们没有强管控，没有说一定要给他停掉。

说话人 1 57:37

对，而且。

说话人 2 57:38

有一些是管控了的，有一些没。

说话人 5 57:40

对，现在是出院的时候，给他一个弹窗，那他可以忽略弹窗，继续出院。然后现在也出现过，比如说一些增强带药的点，虽然之后少不了追溯码，不要。

说话人 1 57:49

是这样的，其实理论上讲的话都，然后 CT 磁盘这些这种理论上都是不应该带出去，你这个该在门诊上完成，应该在门诊上完成，然后刚讲到的实际上这个都是我们医院自己的成本，这个你当然要去做也可以的。

说话人 3 58:03

相当于从医院里面开酒，开店就相当于搞慈善了。

说话人 1 58:07

对的，本身应该在门诊上去完成的，你要在非要在住院门诊，那你就是做慈善。当然门诊和住院它的报销就不一样，有些医生他可能要，会不会患者考虑他可能觉得门诊上面不能报销。当然这个就是看医生对于这个患者的一个，就是医院的一个管理的一个相应的要求。就比如我们会鼓励一些，就是能够缩短平均住院日的，可以适当，但是不要去推荐这个，特别是那种没有做的都忘记退费了，然后导致了费用就提高了，是吧？

说话人 2 58:45

好，看，其他老师还有什么问题？数据统计那边呢。

说话人 1 58:48

我这边。

说话人 2 58:50

还有我们的规培学员们也可以提问。

说话人 1 58:53

我还有一个就是还是刚才那一页，他说增加自费，不能增加那个收入。他那个自费就相当于，比如说他报销的时候，他没有报销那笔钱，然后他也算入他那个就是。加计总数。就减了一点价格。对对对，他算进去，就比如说我们的。派特CT，还有就是我们的一些基因检测，这些话同样是比较不像我们之前费用的这个在里面都是得不到一个说，所以说为什么有时候要求在门诊一定要明确诊断之后再把它就是这个病人你在收入就进行相应治疗，因为本身派特 CT 和这个基因检测，它本身你就医保不支你进入到住院费用里面，对于患者来讲，就对于医院来讲没有什么特别好的一个收益，这样。当然是你该在出院期间做的，要在出院做我们只是强调的是就说这个整条的一个合理性和是这个。

说话人 2 59:56

好的，大家还有什么问题没？

说话人 1 01:00:00

没有了吧。那各位老师还有什么问题？

说话人 2 01:00:02

好的，那我们非常非常谢谢这个李部长给我们带来的今天的一个学习。我觉得这是每个人的个人也切身相关，跟我们工作也切。